APENDICITIS AGUDA

DR. JAMES LINDSAY

EPIDEMIOLOGÍA

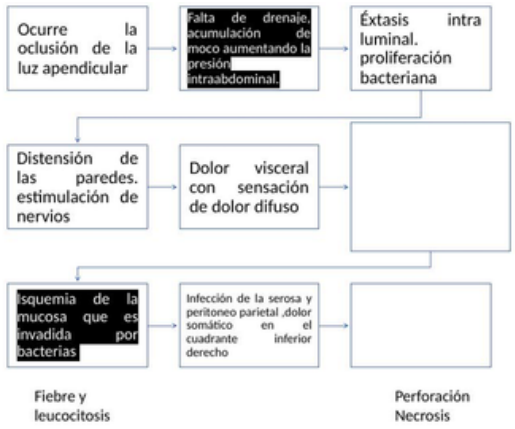
- Afecta al 7–12% de la población; patología aguda más común del abdomen.
- Todas las edades, rara en menores de 3 años; mayor incidencia de 10 a 30 años; ambos sexos.
- Afección quirúrgica más frecuente en urgencias.

CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN

- Hiperplasia linfoide 60%, fecalitos 35–40%, cuerpos extraños 4% (parásitos) y neoplasias 1%.

FISIOPATOLOGÍA

- Obstrucción → moco y proliferación bacteriana → distensión y dolor visceral difuso → isquemia → dolor somático en FID → necrosis o perforación.



ANATOMÍA

- Aparece en la 8.ª semana de gestación como invaginación del ciego.
- Estructura tubular muscular unida al ciego donde convergen las 3 tenias; longitud media 7–8 cm (2–20 cm).
- Base fija respecto al ciego; la punta adopta distintas posiciones.

POSICIONES DEL APÉNDICE

- Retrocecal, retrocólica, paracecal, pélvica y subcecal.

IRRIGACIÓN ARTERIAL

- Arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica (de la mesentérica superior).

DRENAJE VENOSO

- Vena apendicular → vena ileocólica → vena mesentérica superior.

FASE CONGESTIVA O CATARRAL

- Edema y congestión de la serosa, aumento de bacterias y reacción del tejido linfoide.

FASE SUPURATIVA O FLEMONOSA

- Mayor congestión vascular, compromiso venoso y linfático, exudado fibrinoso purulento y proliferación bacteriana.

FASE GANGRENOSA O NECRÓTICA

- Compromiso arterial, venoso y linfático con necrosis de la pared; gran componente inflamatorio y más material purulento.

FASE PERFORADA

- La pared se perfora y libera material purulento y fecal a la cavidad abdominal.



CUADRO CLÍNICO

- Diagnóstico principalmente clínico.
- Dolor periumbilical seguido de náuseas; luego se localiza en FID, vómitos, fiebre y después leucocitosis.

LABORATORIO

- Altamente sugerentes: neutrofilia, proteína C reactiva elevada y leucocitosis.

TOMOGRAFÍA

- Reservarla para el diagnóstico incierto; hallazgos: inflamación y líquido libre.

APENDICITIS AGUDA

DR. JAMES LINDSAY

ESCALAS DE ALVARADO

		Puntos
Síntomas	• Migración del dolor	1
	• Anorexia	1
	• Náuseas/ vómito	1
Signos	• Dolor en cuadrante inferior derecho	2
	• Rebote (+)	1
	• Fiebre	1
Laboratorio	• Leucocitosis	2
	• Desviación a la izquierda de neutrófilos	1
	Total	10

9 - 10 puntos: Casi certeza de apendicitis
> 7 puntos: Alta probabilidad de apendicitis
6 - 5 puntos: Consistentes con apendicitis pero no diagnóstica
≤ 4 puntos: Baja probabilidad de apendicitis aguda

APENDICITIS EN NIÑOS

- Riesgo de perforación mucho más alto en lactantes y niños (hasta 30%); diagnóstico difícil, se recurre más a imágenes.

APENDICITIS EN ANCIANOS

- Riesgo muy alto de perforación y síntomas inespecíficos.

APENDICITIS EN EL EMBARAZO

- Urgencia quirúrgica más frecuente en embarazadas, sobre todo en el segundo trimestre; laparoscopía segura en todos los trimestres.

SIGNO DE AARÓN

- Dolor en epigastrio o región precordial al presionar el punto de McBurney.

SIGNO DE HOLMAN

- Dolor a la percusión suave sobre la zona de inflamación peritoneal.

SIGNO DE DUNPHY

- Incremento del dolor en la FID con la tos.

OTROS SIGNOS EXPLORADOS

- Punto de McBurney, Rovsing, psoas, obturador y Blumberg (dolor provocado en la FID).

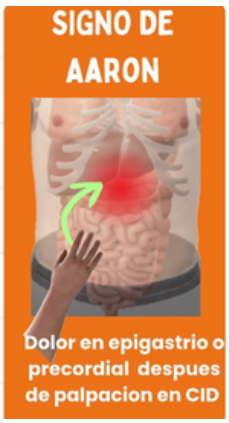












ULTRASONIDO

- Útil cuando hay duda diagnóstica y en mujeres para diferenciar procesos ginecológicos.

RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN

- Íleo localizado en el CID con niveles hidroaéreos (asa centinela), líquido en ciego o colon ascendente, engrosamiento de pared, fecalito calcificado (5–10%) y borramiento del psoas.

COMPLICACIONES

- Perforación, plastrón apendicular, infección de la herida, fístulas enterocutáneas, absceso intraabdominal, peritonitis generalizada, sepsis y obstrucción por adherencias.

TRATAMIENTO MÉDICO

- Antibioticoterapia exclusiva en casos seleccionados no complicados, sobre todo confirmados por TAC; recidiva al año del 20–30%.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Apendicectomía laparoscópica: estándar actual (menos dolor, menor estancia, mejor recuperación).
- Abierta: útil con recursos limitados o complicaciones.

ACTUALIZACIONES 2023–2025

- Antibióticos (CODA, APPAC), IA, cirugía ambulatoria y antibióticos cortos (24–48 h).